

Temblor, Parkinson y Síndromes Extrapiramidales

Tipos de Temblor

TABLA 12.11.1: TIPO VS CUÁNDO APARECE			
TIPO	CUÁNDO APARECE	CARACTERÍSTICAS	TRATAMIENTO
Esencial	Al adoptar postura o tomar objeto	Bilateral, simétrico; puede afectar cabeza y voz	Propranolol
Parkinsoniano	En reposo	Asimétrico; desaparece al tomar el objeto	Levodopa + carbidopa
Cerebeloso (dismetría)	Al intentar tomar objeto	Empeora al acercarse; no tiembla en reposo	Tratar causa

Enfermedad de Parkinson

Triada clásica

1. Temblor de reposo (asimétrico, "cuenta monedas") 2. Rigidez ("en rueda dentada") 3. Bradicinesia (movimientos lentos)

Síntomas adicionales

- Hipomimia (cara inexpresiva) - Pérdida del braceo al caminar - Disminución del pestañeo - Marcha festinante
- Diagnóstico: clínico (no requieren exámenes)
- Tratamiento: levodopa + carbidopa (agonistas dopaminérgicos)
- Parkinson terminal + demencia = si la demencia fue PRIMERO → Demencia por cuerpos de Lewy

Síndrome Cerebeloso

- Dismetría + adiadococinesia + ataxia (tríada)
- Nistagmo multidireccional (vértigo central)
- Lesiones cerebelosas son ipsilaterales (≠ lesiones cerebrales = contralaterales)
- Diagnóstico: RNM (buscar causa); cerebelitis post-varicela = benigna, educar

Extrapiramidalismos por Fármacos

Fármacos causantes: antipsicóticos y antieméticos → antidopaminérgicos

TABLA 12.11.2: SÍNDROME VS CLÍNICA			
SÍNDROME	CLÍNICA	TIEMPO	TRATAMIENTO
Parkinsonismo	Triada: temblor + rigidez + bradicinesia	Días-semanas	Suspender fármaco
Distonía aguda	Contractura dolorosa: tortícolis, crisis oculógira, trismo	Primeras horas-días	Suspender + BZD EV (lorazepam/diazepam)
Acatisia	Inquietud interna, necesidad de moverse	Días-semanas	Suspender o ↓ dosis + propranolol o BZD
Disquinesia tardía	Movimientos reptantes boca/lengua → extremidades	Meses-años	Suspender pronto; daño puede ser permanente

Corea

- Sydenham (menor): fiebre reumática → transitoria; criterio de Jones
- Huntington (mayor): autosómico dominante → incurable → evoluciona a demencia

Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM)

- Triada: hipertonia + hipertermia + compromiso de conciencia
- Tras inicio o aumento de dosis de antipsicótico
- Tratamiento: suspender fármaco + medidas físicas (ABC) + BZD + dantroleno

Vs. Hipertermia Maligna: clínica idéntica, pero desencadenada por anestesia (succinilcolina o gases halogenados). Tratamiento igual (dantroleno).

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Paciente de 35 años presenta debilidad progresiva de 5 días de evolución que comenzó en las piernas y ahora afecta también los brazos. Al examen hay hipotonía y arreflexia generalizada. Hace 2 semanas tuvo un cuadro de diarrea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Síndromes Motores. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- 1era motoneurona (piramidal): hipertonia, hiperreflexia, clonus, Babinski. 2da motoneurona (denervación): hipotonía, hiporreflexia, fasciculaciones, atrofia marcada.
- En AGUDO el piramidal puede presentarse con hipotonía e hiporreflexia (luego evoluciona al patrón clásico).
- Miopatías: debilidad PROXIMAL, sin atrofia, solo motoras. Neuropatías: debilidad DISTAL, con atrofia, con síntomas sensitivos.
- Miastenia gravis: anti-receptor nicotínico, NO afecta SNA, EMPEORA con repetición, tímoma. Lambert-Eaton: anti-canales Ca presinápticos, SÍ afecta SNA, MEJORA con repetición, cáncer pulmón células pequeñas.
- Guillain-Barré: tetraparesia flácida arrefléctica progresiva, post-infecciosa (Campylobacter). PL: disociación albúmino-citológica. Tratamiento: plasmaféresis o IgG alta dosis.
- Miller-Fisher = Guillain-Barré + neuropatía craneal múltiple. No confundir con miastenia gravis (fluctuante, crónica).
- Botulismo vs Guillain-Barré: botulismo es exclusivamente motor, en lactante <1 año (miel), o afecta múltiples personas.
- Mielitis transversa vs Guillain-Barré: nivel sensitivo + afectación de esfínteres + dolor dorsal → mielitis. Tratamiento: corticoides.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (SÍNDROMES MOTORES)**PREGUNTA 1**

Paciente de 35 años presenta debilidad progresiva de 5 días de evolución que comenzó en las piernas y ahora afecta también los brazos. Al examen hay hipotonía y arreflexia generalizada. Hace 2 semanas tuvo un cuadro de diarrea. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Mielitis transversa
- B)** Esclerosis Múltiple
- C)** Síndrome de Guillain-Barré
- D)** Miastenia gravis
- E)** ELA

PREGUNTA 2

Paciente de 50 años presenta ptosis y diplopía fluctuantes. La debilidad empeora con los movimientos repetitivos. Se encuentra un timoma en el TAC de tórax. ¿Cuál es el diagnóstico?

- A)** Síndrome de Lambert-Eaton
- B)** Miastenia gravis
- C)** Síndrome de Miller-Fisher
- D)** Parálisis de nervios craneales por tumor
- E)** Oftalmopatía de Graves

PREGUNTA 3

¿Cuál de las siguientes características diferencia la mielitis transversa del síndrome de Guillain-Barré?

- A)** Presencia de debilidad en extremidades inferiores
- B)** Presencia de nivel sensitivo y afectación de esfínteres
- C)** Antecedente de infección previa
- D)** Presencia de dolor
- E)** Afectación de nervios craneales

RESUMEN: SÍNDROMES MOTORES

Esta clase aborda los síndromes motores: diferenciación entre primera y segunda motoneurona, miopatías vs neuropatías, miastenias, síndrome de Guillain-Barré y mielitis transversa. El síndrome piramidal (1era motoneurona) se caracteriza por paresia con hipertonía, hiperreflexia, clonus y Babinski, causado por AVE o lesión medular. El síndrome de denervación (2da motoneurona) presenta paresia con hipotonía, hiporreflexia, fasciculaciones y atrofia marcada, causado por desmielinización periférica (Guillain-Barré, polineuropatías). En agudo, el piramidal puede presentarse con hipotonía e hiporreflexia. Las miopatías (polimialgia reumática, polimiositis, Duchenne) producen debilidad proximal sin atrofia. Las neuropatías producen debilidad distal con atrofia y alteraciones sensitivas. La miastenia gravis (autoinmune, anticuerpos anti-receptor nicotínico) produce debilidad fluctuante de músculos oculares (ptosis, diplopía), empeora con repetición y se asocia a timoma. El síndrome de Lambert-Eaton (anti-canales de calcio presináptico) afecta SNA, mejora con repetición y se asocia a cáncer pulmonar de células pequeñas. El Guillain-Barré es una desmielinización aguda del SNP, post-infecciosa (diarrea por *Campylobacter*), con tetraparesia flácida arrefléctica progresiva. Diagnóstico clínico con EMG y PL (disociación albúmino-citológica). Tratamiento: plasmaféresis o IgG en alta dosis. El síndrome de Miller-Fisher es Guillain-Barré con neuropatía craneal múltiple. La mielitis transversa se diferencia por nivel sensitivo, afectación de esfínteres y dolor dorsal.